

とされる。喀痰の臭気も重要な情報となり、腐敗臭を呈する場合は肺膿瘍など嫌気性菌感染を、洗濯物の生乾き臭を呈する場合はモラクセラ菌の感染を疑う。喀痰からの嫌気性菌の検出は困難であり、臭気は重要な手がかりとなる。

感染症が疑われる痰では培養を行うが、結果判明には時間を要する。結核菌、一部の非結核性抗酸菌、肺炎マイコプラズマやニューモシスチスには核酸増幅法による検出が可能である。また肺炎球菌や肺炎マイコプラズマなどでは喀痰中の抗原の迅速検査が可能である。Gram 染色は結果が短時間で判明するが、検体として有用な痰であるか Geckler 分類 (表 2) で顕微鏡的に評価する。原因菌診断に有用な痰は Geckler 4 群、5 群が該当し、良質の検体を用いた場合には 60～70% 程度の感度とされる²⁾。その他抗酸菌では蛍光染色や Ziehl-Neelsen 染色が、レジオネラ・ニューモフィラではヒメネス染色が用いられる。

細胞診は悪性腫瘍以外にも呼吸器系炎症の病態把握に有用で、喀痰中好酸球や好中球は治療の参考となる。

ii) 画像検査および呼吸機能検査

多くの場合、喀痰検査のみでの診断は困難であり、胸部 X 線、CT、呼吸機能検査や必要に応じ気管支鏡検査などを総合して判断する。

治療

原因疾患の治療が基本だが、対症療法である喀痰調整薬を使用する場合がある。薬効判定は客観的な評価法が存在していないが、喀痰量、粘稠度、喀出しやすさなどに基づいて判断する¹⁾。喀痰調整薬は COPD の増悪抑制効果を有することも報告されており、回数の有意な低下が報告され有用性が見直されている³⁾。

喀痰調整薬以外の薬物として、気管支拡張薬、DPB に対してのマクロライド系抗菌薬の少量長期投与が知られている。膿性痰の存在は一般に細菌感染を示唆し、慢性気管支炎においては黄色や緑色の膿性痰が重視され、COPD の増悪においても膿性痰が抗菌薬投与の根拠となることが多い³⁾。また、体位ドレナージなど、排痰のための理学療法も喀痰症状の制御に有用である⁴⁾。

文献

- 1) 日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第 2 版作成委員会 (編)：咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025。メディカルレビュー社、2025
- 2) 日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン 2024 作成委員会 (編)：成人肺炎診療ガイドライン 2024。日本呼吸器学会、2024
- 3) 日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会 (編)：COPD (慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン、第 6 版。メディカルレビュー社、2022
- 4) Bott J, et al : Thorax 64 Suppl 1 : i1-51, 2009